

Uważność w AvPD

Obserwowanie wstydu i lęku z **dystansem**, bez reagowania ucieczką. Kocovski 2009 (MAGT, RCT): $d = 0,89$ dla lęku społecznego. Defuzja od myśli — przestrzeń między bodźcem a reakcją.

CZAS: 10 min/dzień Codzienna praktyka

ŹRÓDŁO: Kabat-Zinn (1979); Segal i wsp. (2002); Hayes (1999); Kocovski (2009)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz mechanizm *fuzji z myślą* w AvPD (sekcja 01). **2** · Poznasz **defuzję ACT** i jej działanie (sekcja 02). **3** · Wypełnisz *plan praktyki*: 10 min/dzień formalna + nieformalna (sekcja 03). **4** · Poznasz **warunek transferu**: medytacja na poduszce *nie* wystarczy, AvPD aktywuje się w sytuacjach społecznych (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Uważność w AvPD oznacza praktykowanie obecności w sytuacjach, które rdzeniowo chce się **unikać** — obserwowanie wstydu i lęku z **dystansem**, bez reagowania ucieczką. Kocovski i wsp. (2009, RCT): *Mindfulness and Acceptance-Based Group Therapy* (MAGT) w lęku społecznym osiąga **$d = 0,89$** . Domyślny mode w AvPD to *fuzja z myślą*: „mam myśl *jestem wadliwy*” → „**jestem wadliwy**”. Brak przerwy między bodźcem a reakcją. Wstyd staje się „prawdą”, lęk „sygnałem niebezpieczeństwa”, unikanie jest natychmiastowe i nieświadome. Praktyka defuzji (ACT/MBCT): „mam myśl, że *jestem wadliwy*” zamiast „*jestem wadliwy*”. Drobną zmianą językową tworzy **przestrzeń** między obserwatorem a treścią. W tej przestrzeni można *wybrać* reakcję — pozostać w sytuacji mimo dyskomfortu, działać zgodnie z wartościami, a nie z impulsem ucieczki. Regularna praktyka osłabia *domyślną sieć neuronalną* (DMN) odpowiedzialną za ruminację i samokrytycyzm (Brewer i wsp. 2011).

01 Fuzja z myślą — domyślny tryb AvPD

FUZJA — BRAK PRZERWY

„Mam myśl *jestem wadliwy*” → „**jestem wadliwy**” → unikanie. **0 sekund** między myślą a reakcją. Myśl jest *traktowana jako fakt*. Reakcja automatyczna, nieświadoma.

DEFUZJA — PRZESTRZEŃ WYBORU

„Zauważam, że mam myśl, że *jestem wadliwy/-a*” → przestrzeń → **wybór**. Myśl jest *obserwowana*, nie wcielana. W tej przestrzeni można zostać w sytuacji.

Klucz: fuzja to *nie tylko* kwestia językowa — to **tryb neuropoznawczy**. Domyślna sieć neuronalna (DMN, Brewer 2011) generuje ruminację i samokrytycyzm w trybie automatycznym. Uważność *osłabia DMN*, wzmacnia sieci wykonawcze. Mózg uczy się **obserwować myśli zamiast się w nich rozplątać**.

02 Defuzja ACT — przestrzeń między bodźcem a reakcją

FUZJA — automat
bodziec → myśl = ja → reakcja (ucieczka)

DEFUZJA — wybór
bodziec →

zauważam myśl → wybór → akcja **PRZED SYTUACJĄ: 3 ŚWIADOME ODDECHY + INTENTION SETTING**

„jest mi trudno I IDE” — schemat zostaje, ale nie dyktuje akcji

Praktyczne techniki defuzji: (1) „Zauważam, że mam myśl, że...” zamiast „jestem...”. (2) Wyobrażenie myśli jako *chmury* przepływającej po niebie. (3) Powiedzenie myśli głosem postaci z bajki — *oddziela* emocjonalny ładunek. (4) Podziękowanie umysłowi: „dzięki umyśle, że mnie chronisz” — bez walki.

03 Mój plan praktyki uważności

FORMALNA — 10 MIN/DZIEŃ

— kiedy, gdzie? rano lub wieczorem?

NIEFORMALNA — W CIĄGU DNIA

— np. 3 świadome oddechy przy spotkaniu

SYTUACJA SPOŁECZNA DO TRENINGU

— gdzie zastosuję defuzję?

KONKRETNA FRAZA DEFUZJI

— „zauważam, że mam myśl, że...” + treść

04 Warunek transferu — sama poduszka nie wystarczy

PULAPKA „MEDYTACJA JAKO SAFETY”

Pacjent medytuje 30 min/dzień *w domu*, ale unika spotkań. **AvPD nie aktywuje się na poduszce** — aktywuje się w sytuacjach społecznych. Sama formalna praktyka *nie* zmienia AvPD.

TRANSFER W SYTUACJE

Formalna medytacja (10 min/dzień) + nieformalne zauważanie w ciągu dnia + stosowanie defuzji w sytuacjach społecznych. Tylko trzy razem zmieniają wzorzec.

Klucz: uważność w AvPD *nie* jest relaksacją — jest **treningiem defuzji**. Domyślny tryb AvPD to fuzja: „myśl = ja”. Defuzja tworzy *przestrzeń*: „mam myśl, że...”. W tej przestrzeni można wybrać działanie zgodne z wartościami zamiast impulsu ucieczki. Brewer 2011: regularna praktyka osłabia DMN (ruminacja, samokrytycyzm), wzmacnia sieci wykonawcze. **Warunek skuteczności:** regularność (10–20 min/dzień), długoterminowość (efekty po 8–12 tygodniach), **i transfer w sytuacji**. Sama medytacja na poduszce *nie* zmienia AvPD — AvPD aktywuje się w kontakcie z ludźmi, nie w samotności. Kocovski 2009 (MAGT, RCT): $d = 0,89$ — gdy formalna praktyka jest połączona z ekspozycją grupową.